

Un adolescent autiste dans votre cabinet

Pour les médecins de famille, les infirmiers et les professionnels de la santé mentale — soigner un adolescent autiste (environ 12 à 18 ans).

L'idée centrale

L'autisme, vu sous l'angle du **monotropisme**, signifie que l'attention d'un adolescent se verrouille dans quelques « tunnels » profonds et intenses. La puberté et l'adolescence accumulent des exigences à canaux multiples — règles sociales changeantes, identité, rencontres, changements corporels — sur un système pour lequel le basculement rapide est coûteux. C'est l'**âge critique pour l'anxiété, la dépression et le burnout**, et beaucoup d'adolescents autistes (particulièrement les filles et les genres marginalisés) ne sont **identifiés qu'au moment d'une crise**. Traitez le jeune comme l'expert de sa propre expérience.

Ce que vous pouvez observer — et ce qui se passe réellement

Vous observez...	Ce qui se passe souvent
Épuisé, retiré, « n'a pas la force » ; refuse l'école	Probable burnout autistique ou surcharge — distinct de la dépression ou de la paresse
Automutilation, pensées suicidaires ou présentation en crise	Risque réel et élevé dans ce groupe ; souvent le premier signe d'un besoin non satisfait
Intérêts intenses et envahissants ; résiste à l'idée d'y renoncer	Les intérêts sont l' identité, la régulation et la récupération — pas des obsessions à limiter
« Tout va bien » pendant le rendez-vous, s'effondre après	Camouflage intensif ; le prix est payé plus tard
Besoin de contact écrit, évite le contact visuel, longues pauses	Communication sur un canal unique + temps de traitement, et non de l'impolitesse

Essayez ceci

- **Proposez l'outil AASPIRE AHAT** avant la visite et une option de rendez-vous **écrit ou en ligne** ; beaucoup d'adolescents communiquent bien mieux par écrit.
- **Interrogez directement et séparément** sur l'humeur, l'anxiété, le burnout, le sommeil, l'alimentation et les pensées suicidaires — en utilisant des questions concrètes et littérales.
- **Validez leurs intérêts** comme légitimes ; demandez-leur ce qu'ils aiment et protégez l'accès à ces activités.
- **Laissez du temps de traitement** ; proposez d'envoyer un résumé écrit après la visite.
- **Impliquez-les dans les décisions** et respectez leur autonomie ; établissez une routine de suivi prévisible et à faible charge sensorielle.

Évitez ceci

- Confondre le **burnout autistique avec la dépression** — traiter cela comme une dépression (ou dire « fais plus d'efforts ») peut aggraver la situation et augmenter le risque suicidaire.

- Pousser l'adolescent à camoufler, à maintenir le contact visuel ou à « être plus sociable » comme objectif.
- Supposer qu'une réponse lente ou inhabituelle signifie qu'ils ne comprennent pas ou manquent de capacité.

Quand demander plus de soutien

Dépistez directement la suicidalité — les adolescents autistes sont plus à risque. Distinguez le **burnout autistique** (épuisement + perte de compétences + tolérance réduite aux stimuli ; nécessite *une réduction des exigences, de l'acceptation et la permission de démasquer*) de la dépression. Traitez concrètement les besoins sensoriels et pratiques liés à la puberté (menstruations, hygiène). Planifiez la **transition vers les services pour adultes tôt**, avec les intérêts du jeune au centre. Orientez vers des groupes de pairs autistes et des mentors — une amitié de qualité est un puissant facteur de protection.

Si l'adolescent est une fille ou d'un genre marginalisé

Le camouflage atteint un sommet ici et conduit à beaucoup de diagnostics manqués et de coûts pour la santé mentale. La présentation peut ressembler à une personne « anxieuse, perfectionniste, socialement adaptée en surface ». Interrogez spécifiquement sur l'**épuisement lié au masque** et les symptômes internalisés.

À propos de ce guide

Assisté par IA, dérivé des brouillons de recherche du projet — le brief **Monotropisme** et le **Guide pour les praticiens et professionnels de santé** (Parties 3.3 & 4). Utilise le langage identitaire. **Informatif** — *ce n'est pas un avis médical ni un outil de diagnostic*. Adaptez-le à l'individu.

Sources clés. Murray, Lesser & Lawson (2005); Murray, F. (2023); Dwyer (2025); Raymaker et al. (2020, burnout); Pearson & Rose (2021, masking); Bradley et al. (2021, camouflaging); AASPIRE AHAT; Autism Awareness Australia (santé mentale des ados). Les citations complètes se trouvent dans les brouillons sources.